

13. Depuración de los ejemplos iniciales

Estas correcciones se integran en las fichas para evitar reglas demasiado deterministas.

Borrador inicial	Versión segura para la ficha
"Hawkins = bursa; Neer = supra"	Hawkins y Neer provocan dolor subacromial; no localizan de forma fiable bursa frente a tendón.
"FABER ++++ = cadera"	Interpretar localización: ingle apoya cadera; posterior puede ser SI/lumbopélvico. Integrar rotación interna, FADIR, marcha e imagen.
"PENG positivo demuestra cadera"	PENG es analgésico periarticular. Para hip-spine, preferir infiltración intraarticular con prueba funcional antes/después.
"Caudal alivia 6 meses; si dura 4 meses → PRF DRG"	La epidural ofrece beneficio principalmente corto y variable. Reevaluar antes de repetir; PRF de DRG no es escalón automático.
"Prednisona 30 mg descendente para cervicobraquialgia"	No usar como pauta universal; evidencia limitada, contraindicaciones y necesidad de descartar déficit/mielopatía.
"HA 6-12 meses; PRP mejor a un año"	No prometer duración ni superioridad. HA no se recomienda de rutina en rodilla y se desaconseja en cadera; PRP tiene evidencia limitada/heterogénea.
"PRP repara rotura completa del supra"	No regenera ni repara una rotura completa. La guía AAOS 2025 no apoya uso rutinario en tendinopatía/rotura parcial y considera no indicado rutinariamente en rotura completa no operada.
"Dolor 7-9 = bloqueo"	La intensidad contribuye, pero se decide con función, sueño, duración, diagnóstico, banderas rojas, alternativas y preferencias.
"Líquido ámbar = benigno"	El aspecto macroscópico no excluye infección ni cristales; analizar cuando el contexto lo exige.